

הרעלות ומיכון יתר



תסמונות גמילה

- לכל חומר הגורם לתלות גופנית ישנה תסמונת גמילה אופיינית
- ככלל - הסימנים של תסמונת הגמילה יהיו הפוכים מסימני הרעל/סם/חומר
 - למשל: חומרים מעוררים - תסמונת הגמילה תתאפיין בדיכוי יתר; חומרים מדכאים - תסמונת הגמילה תתאפיין בעוררות יתר
 - כאשר מדובר על סם הגורם לתלות נפשית יופיע גם "קרייבינג" (Craving) - הרצון לסם
- כמו-כן, לרוב תסמונת הגמילה איננה מסוכנת או מסכנת חיים ברמה המיידית
 - אם-כי, ישנה לעיתים סכנה למטפל
 - אך ישנן תסמונות גמילה מסוכנות, כמו למשל בתסמונת גמילה מאלכוהול - Delirium Tremens
- הטיפול הכללי הינו סימפטומטי ויש לצפות לתסמונות אלו ולהכיר אותן
 - בעיקר בעת מתן אנטידוטים (למשל מתן נלוקסון למינון-יתר של אופיואידים)

גישה למכורים

- יש לזכור כי התמכרות הינה מחלה וכי חלק גדול מהמכורים הגיעו למצב זה בעקבות שימוש חוקי בתרופות ולאחר מכן חלה הדרדרות ל"סמי רחוב"
- הימנעו מהעברת שיפוט, זלזול והתנשאות כללית בפני ומאחורי הסובלים מהתופעה
- הימנעו מכינויי גנאי כגון "אלכוהוליסט" ו-"נרקומן"
- התייחסו לכל אדם ומטופל באשר הוא ונסו להבין את מצוקתו
 - אם המטופל מביע רצון אובדני - התייחסו לכך ברצינות
 - אם המטופל מביע רצון להיגמל - הפנו אותו לטיפול המתאים דרך צוות המלר"ד
- מחקרים רבים הראו כי רוב המכורים לתרופות וסמים נמנעים מהגעה לטיפול רפואי עקב חוויה קודמת לא טובה מצד אנשי הרפואה
 - כך נמנע מהמטופלים להשיג ולקבל עזרה גם עבור בעיות בריאות אחרות וברות טיפול
- רוב המכורים אינם אלימים ואינם פושעים

הגישה להרעלה

• ABC

• טיפול תומך בהתאם לסימנים

• ניסיון איתור חומרים שגרמו להרעלה (זהירות ממחטים)

• התאמת הסימפטומים לפי מאפייני הסם או התאמת החומר שנמצא לסכנות הצפויות וטיפול בהתאם (דורש היכרות עם החומרים)

• יש לשלול גורמים נוספים לירידה ברמת ההכרה כגון היפותרמיה, טראומה והיפוגליקמיה

• סקירת מערכות מלאה ושימוש בכלל אמצעי הבדיקה והניטור המתאימים

• היסטוריה רפואית, כולל שלילת אובדנות

דגשים נוספים

- תשומת לב לריחות ספציפיים
- לקיחת/צילום אריזות החומרים
- התייעצות עם המוקד הרפואי אודות טיפול שאינו בפרוטוקול
- שימו לב לסימנים הסותרים את סיפור המקרה (הסתרה, פלילים..), למשל חומר הגורם לעוררות יתר והמטופל מחוסר הכרה
- אין לעודד הקאה, לתת משלשלים, לאלתר אנטידוטים או כל דבר אחר שאינו תחת פרוטוקול טיפולי מוכר
- מוקד הרעלות ארצי 04-7771900 במקרים חריגים (שיחה מוקלטת בלבד דרך המוקד הרפואי)

טיפול ברמת ביה"ח

- גם בבית החולים לא לכל חומר ישנו אנטידוט
- הטיפול העיקרי הינו טיפול תומך ובדיקת שתן ודם למציאת חומרים נפוצים

כמו-כן ישנם טיפולים המקובלים לחומרים ספציפיים:

- הבססת שתן
- בחלק מהרעלים, ניתן להעלות pH וע"י כך למנוע ספיחה מחדש של הרעלן
- פחם פעיל (SDAC)
- שטיפת קיבה
- דיאליזה
- עירוי דם